

H

血管炎を伴う肺病変（多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症）

ANCA-associated vasculitis of the lungs

到達目標

- 抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連血管炎（ANCA-associated vasculitis：AAV）の概要を理解できる
- 臓器障害症候を有する場合や臓器障害徴候がない高齢者において、原因不明の炎症が持続する場合にはANCAを測定することができる
- AAVに合併する多彩な肺病変パターンを理解できる
- AAVの治療である「寛解導入療法」と「寛解維持療法」を理解できる

疾患概念

抗好中球細胞質抗体関連血管炎（anti-neutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis：AAV）とは、免疫複合体の関与しない（pauci-immune型）血管炎のうち、抗好中球細胞質抗体（anti-neutrophil cytoplasmic antibody：ANCA）と認識される疾患標識抗体に基づいて総称される疾患群である。AAVは全身型と臓器限局型に分類され、全身型AAVには、顕微鏡的多発血管炎（microscopic polyangiitis：MPA）、多発血管炎性肉芽腫症（granulomatosis with polyangiitis：GPA）、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（eosinophilic granulomatosis with polyangiitis：EGPA）が含まれる¹⁾。

臨床像

全身性血管炎ではしばしば発熱、全身倦怠感、食不振、体重減少、筋肉痛、関節痛などの非特異的な全身症状を呈する。AAVでは腎臓をはじめ多彩な臓器障害をきたすが、中でも皮膚、末梢神経障害、眼、耳鼻咽喉、気管・気管支や肺の臓器障害はしばしば症状を呈しそれらが受診動機となる。

a GPA

GPAは、1939年、ドイツの病理学者Wegenerによって報告された疾患で、主に小型血管から中型血管（毛細血管、細静脈、細動脈、動脈、静脈）を障害する壊死性肉芽腫性血管炎を特徴とした全身性炎症性疾患である。50～60歳代での発症が多い。①上気道病変（鼻、副鼻腔、中耳、強膜、角結膜、眼窩）、②下気道病変（気管支、肺）、③腎病変（壊死性半月体形成性腎炎）が典型的な所見である。通常は①⇒②⇒③の順序で病態が進行し、①②③のすべてがそろっている場合を全身型、いずれか2つの病変のみの場合を限局型と分類する。2012年、Chapel Hill会議で、病態を適切に表す病名への変更が決定され、以前の名称であるWegener肉芽腫症からGPAと名称が変更され

た²⁾。発熱、体重減少、全身倦怠感などの全身症状とともに、呼吸器症状をはじめさまざまな症状を呈する。

b EGPA

1951年にChurgとStraussが13例の喘息、末梢血好酸球増多および多臓器に血管炎を呈した症例を報告したことから始まっている。病理組織学的には、多臓器の組織および血管壁に著明な好酸球浸潤を伴う壊死性血管炎および血管外肉芽腫形成が認められる。発病に先行してアレルギー性鼻炎や喘息などの症状が認められることが多い。特に難治性喘息（特にアトピー性素因がない）として加療されている患者で、経過中に発熱や好酸球増多が出現した際は、本疾患の可能性が高くなる。喘息発症からEGPA発症まで数年以内が典型的であるが、10～20年以上の長期の喘息歴から発症する症例も少なくない。また、血管炎症状として、肺病変（肺出血、間質性肺炎、胸膜炎など）、多発性単神経炎（痺れなどの異常感覚や運動機能障害が重度の場合には、下垂足や下垂手の状態に陥る）、皮膚病変（紫斑、皮下出血）、消化管出血、心病変（心筋梗塞、心膜炎）、筋炎なども認められるが、腎症は少ない。

検査所見

a GPA

GPAでは、患者の80%以上は上気道症状で発症する。しかしながら、そのような早期症例では血清proteinase 3-ANCA（PR3-ANCA）が検出されない場合やGPAに特徴的な病理組織学的所見を認めない場合も多い。したがって、典型的な全身症状や検査所見が出現してから本疾患と診断され、治療に難渋する症例も少なくない。

i) 血液検査

末梢血白血球数および血小板数の増加に加え、CRP上昇、赤沈亢進、貧血を認める。好酸球増多も約半数の症例で認める。腎病変合併例では、血尿、蛋白尿、血清クレアチニン上昇、クレアチニンクリアランス低下が認められる。

ii) 胸部画像所見

典型的には、数mmから10cm大の結節および腫瘍性病変が両肺多発性に認められる。これらの病変は胸膜下や気管支血管周囲にもみられ、約50%の症例で空洞を有する。空洞の壁厚はさまざまで、ときに空洞内に滲出物の貯留が認められる（図1a）。その他、主に肺出血を反映した浸潤影、すりガラス陰影や区域あるいは亜区域気管支壁の肥厚、胸膜肥厚ならびに胸水などを呈する場合もある。